业财融合视域下
卫生健康经济管理人才培养
调查分析报告

基于162份问卷的人才需求与培养路径分析

本报告围绕培养对象、能力短板、课程需求、实践方式和组织保障展开，为卫生健康经济管理人才培养项目提供决策参考。

调查呈现出清晰的培养方向：将业务理解与数据分析共同作为重点，以运营管理项目连接课程与岗位实践，并把导师指导、过程跟踪和成果运用纳入日常管理。

分析日期 2026年10月17日

汇总报告 管理汇报修订版

阅读导航

一 主要发现与管理启示

二 调查对象与阅读口径

三 培养现状与资源配置

四 能力短板与人才需求

五 课程安排与实践方式

六 组织保障与职业发展

七 分组结果与培养安排

八 项目实施建议

附录A 各题统计结果

附录B 统计方法与比较结果

正文按“发现了什么—意味着什么—可以怎样做”展开。各题详细数据及统计检验结果列于附录，配套Excel提供完整计算与核验记录。

一 主要发现与管理启示

业务理解与数据分析应共同成为培养重点

受访者认为，业务能力和数据能力是较突出的短板。66人认为现有队伍的业务能力差距较大，占40.7%；57人认为队伍的数据能力差距较大，占35.2%；财务能力对应比例为25.9%。这说明培养内容需要在财务专业基础上，进一步加强医疗业务理解、运营分析和数据应用。

业务与数据两项评分比较接近，目前还不足以判断哪一项明显更急迫。课程设计宜将两者结合：通过一个实际业务问题，训练流程理解、数据分析和管理建议形成的完整过程。

数智课程需求强烈 现有培训仍有拓展空间

156人认为数智化运营与数据分析课程较有必要，占96.3%；49人报告已有信息化与数据工具培训，占30.2%。其中，109人既表达了较高的数智课程需求，又未勾选现有数据工具培训，占全体受访者的67.3%。这部分需求值得在课程安排中优先关注，并结合实际课程目录确定补充内容。

加强实践机会与持续指导

跟岗实训、项目制学习和真实案例学习获得较多选择。与此同时，108人指出现有培训缺乏持续跟踪，126人指出实践锻炼和项目历练机会不足。培养项目应把课程学习与真实任务衔接起来，使学员在学习之后有机会应用、有导师反馈、有成果评价。

培养重点	调查发现	管理安排建议
人才方向	未来需求前三入选人数：运营133、数据120、综合89	围绕运营问题配置业务、数据和综合协调课程
实践方式	跟岗125、项目95、案例90人列入前三	建设跟岗岗位和项目清单，配套案例复盘
过程管理	108人反映缺乏跟踪；82人反映分层不足	明确阶段目标，按能力基础安排任务
成果运用	126人反映实践机会不足；96人反映激励与结果运用不完善	提供实际应用场景，将成果纳入评价
制度落实	落实到位组报告无系统评估的比例为28.1%，其他组为58.5%	同步建设培养制度与评价工具

本报告据此提出课程与管理改进方向。实施时可先安排小规模试点，以项目成果质量和实际应用情况检验成效，再逐步扩大。

二 调查对象与阅读口径

本次分析包括162名受访者的47题问卷。两个Excel文件是同一批答卷的数值版与文本版，已逐项对照核验，合并用于分析。正文中的人数和比例以受访者为单位，反映本次参与调查人群的意见与情况。

特征	人数与比例	培养设计启示
医院类别	三级145人（89.5%）；二级14人（8.6%）；其他3人	本次需求主要体现三级类别受访者的工作背景
管理岗位	院级领导6人、总会计师14人、部门正职41人、副职30人，共91人	兼顾管理决策、跨部门协同与骨干业务能力
年龄	31至40岁99人（61.1%）	围绕在职发展和能力进阶安排学习任务
学历	硕士88人（54.3%），本科70人（43.2%）	加强知识应用和综合分析训练
职称	正高级25人、副高级50人、中级83人；高级合计46.3%	将培养层次与实际承担任务相结合
专业背景	财务审计类142人（87.7%）	加强医疗业务、医保和信息技术的跨专业学习
部门归属	财务或审计部门109人（67.3%）	拓展财务与临床、运营、信息部门的协作场景

受访者整体具有较好的学历与财审专业基础。人才培养可以更多转向“如何把专业知识用于医疗业务和运营管理”，通过跨部门项目把既有经验与新的数据方法结合起来。

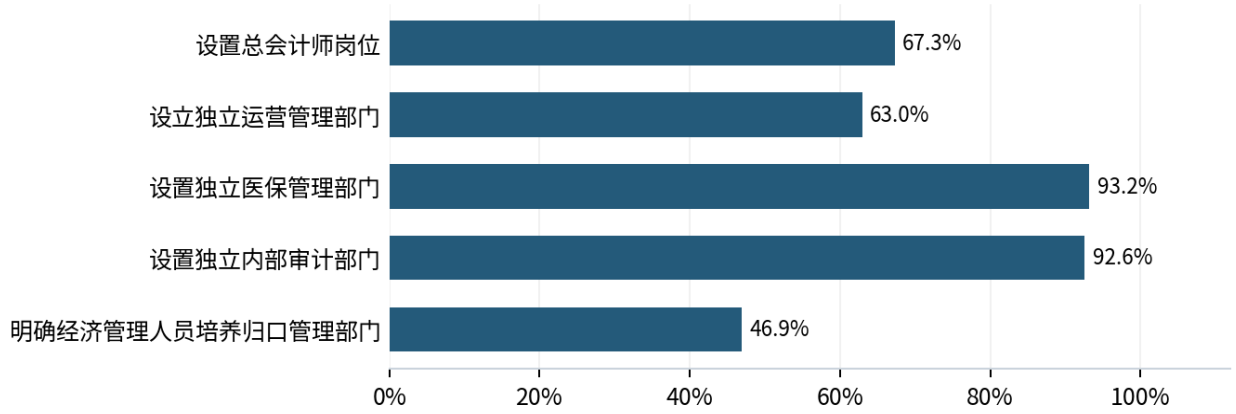
数据怎样阅读

单选题比例表示选择该项的人数占比。多选题允许一人选择多项，因此各项比例相加可以超过100%。排序题同时报告“列入前三”和“列为首选”：前者说明需求覆盖面，后者说明最优先考虑的方向。

五级评分中，4至5分归为较高评价。不同题目中的高分含义随题意变化：能力差距题高分表示短板更明显，课程必要性题高分表示需求更强，职业通道题高分表示更畅通。第11和12题按实际填报记录分别统计，明细见附录。

三 培养现状与资源配置

岗位与机构设置情况



来源 Q10；每项162人，比例为回答“是”的受访者占比

制度建设需要进一步落实到日常运行

32人回答所在机构培养制度落实到位，占19.8%；49人回答已有制度但落实不足，占30.2%；81人回答尚无系统制度安排，占50.0%。管理改进可以分两步推进：先明确培养责任、目标与年度安排，再通过任务分配、过程记录和成果评价推动执行。

在第39题的人才培养组织管理评价中，91人报告已明确人才培养归口管理部门，69人报告已制定中长期培养规划，51人报告已建立培养档案与学时台账。建议将归口管理与具体任务连接起来，由责任部门统筹课程、导师、实践岗位及评价记录。

把有限学习时间优先用于岗位问题

103人的回答落在年人均培训20学时以下或20至40学时两个档次，占63.6%；110人的回答落在年人均经费1000元以下或1000至3000元两个档次，占67.9%。另有82人反映人员配置严重不足或相对不足，占50.6%。课程安排应考虑工作与学习的衔接，采用分阶段任务、集中实训和岗位应用相结合的方式。

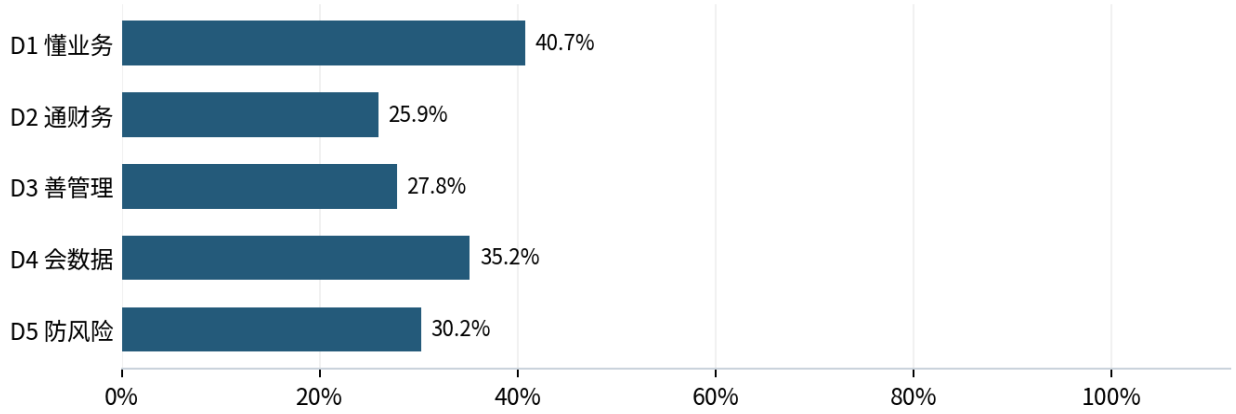
148人报告培养经费来自单位预算，占91.4%；62人报告有主管部门专项经费支持，占38.3%。单位预算是本次填报中最常见的经费来源，建议将导师指导、项目实践和后续评价一并纳入预算安排。

现有管理任务可以直接转化为教学项目

在已开展的业财融合举措中，全面预算管理127人、公立医院绩效考核121人、DRG/DIP支付方式改革109人、全成本核算102人、内部控制与财会监督101人。可围绕这些工作设计项目，让学员使用实际业务流程与数据完成分析，提升学习内容与日常任务的关联。

四 能力短板与人才需求

认为现有队伍各类能力差距较大的受访者比例



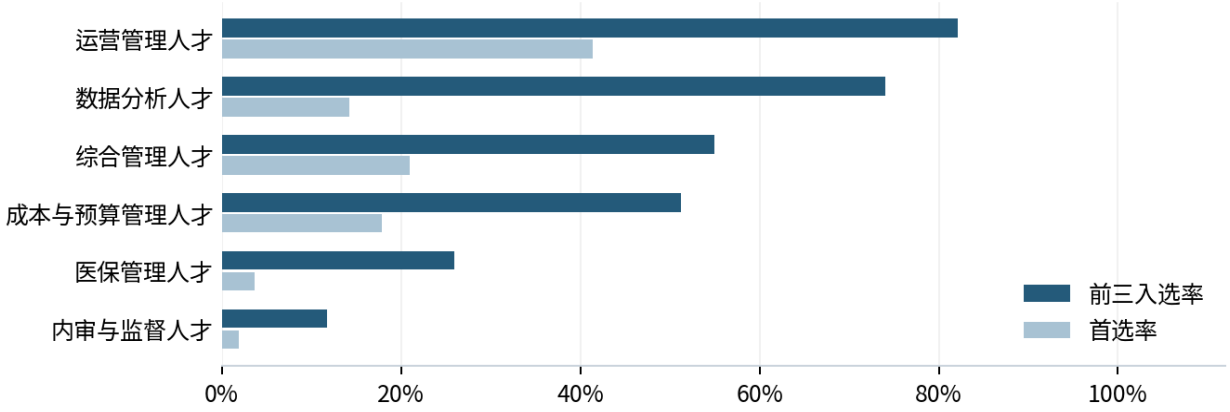
来源 Q22；4至5分表示差距较大；每项162人

能力维度	平均评分	评分中位数	评价差距较大人数	占比
D1 懂业务	3.30	3	66	40.7%
D2 通财务	2.66	3	42	25.9%
D3 善管理	3.09	3	45	27.8%
D4 会数据	3.13	3	57	35.2%
D5 防风险	3.02	3	49	30.2%

五类能力评分存在差异，业务能力与数据能力都是值得重点加强的方向。两者平均评分仅相差约0.17分，现有结果还不足以认定业务短板明显大于数据短板，因此宜作为并列重点统筹培养。

在教学中，可把“理解业务—分析数据—提出改进建议”作为一项连续任务。例如，分析某病种成本时，既要理解诊疗流程及资源消耗，也要会整理数据、判断差异并与业务部门讨论改进措施。这样可以同时训练两类能力。

未来三年人才需求的覆盖面与优先顺序



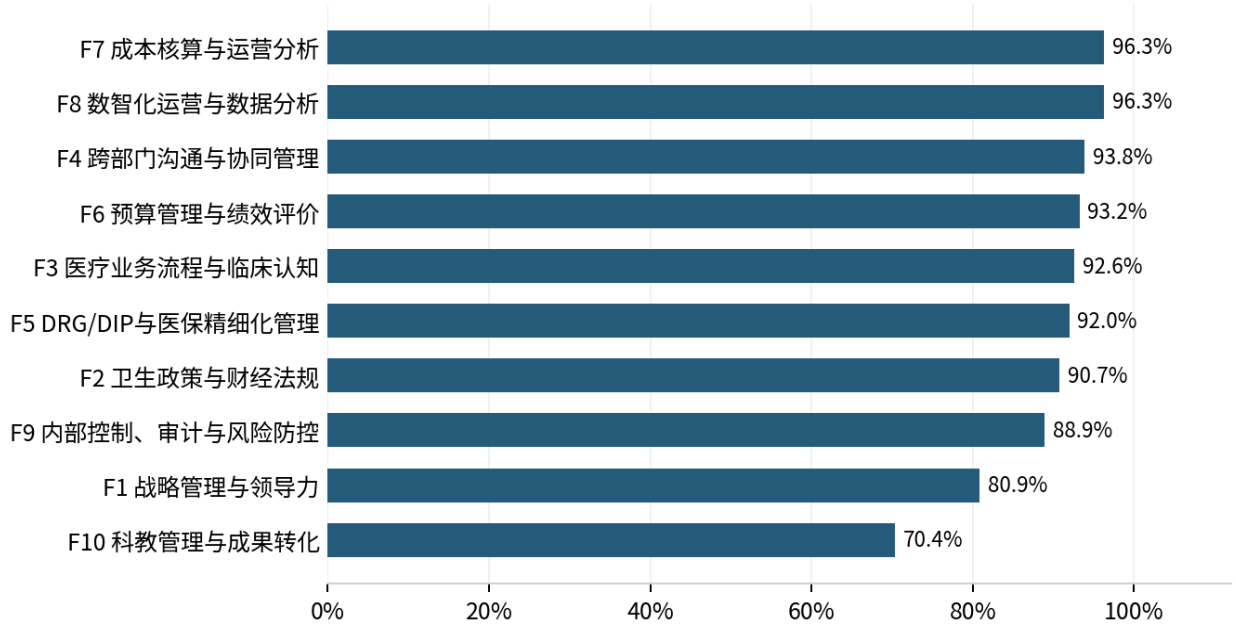
来源 Q23；前三入选率表示列入前三的比例，首选率表示列为第一的比例；每项162人

从需求覆盖面看，运营管理133人、数据分析120人、综合管理89人列入前三，成本与预算为83人。从第一优先选择看，运营管理67人、综合管理34人、成本与预算29人位居前三。运营管理在两种排序中都较突出，适合作为培养项目的核心应用场景；数据分析适合作为支撑多类岗位的共同能力。

医保人才被42人列入需求前三，而医保课程被149人评价为较有必要。这说明“优先配置哪类人才”与“现有人员应学哪些知识”是两个问题。医保政策与支付规则宜作为复合型人才的共同学习内容，与成本、运营和绩效分析结合。

五 课程安排与实践方式

各课程模块的较高必要性评价



来源 Q26；4至5分；每项162人

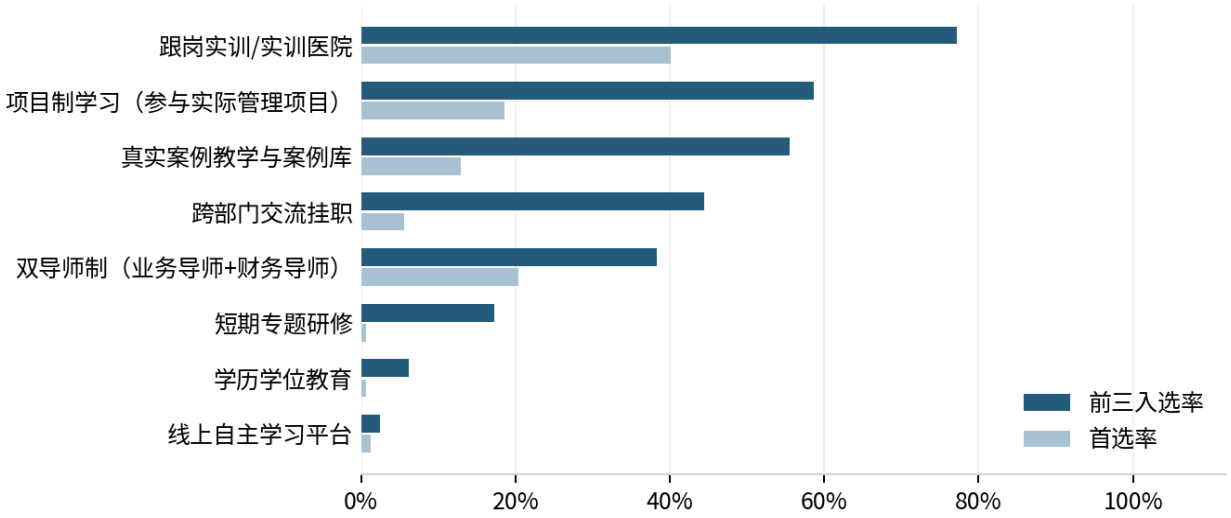
多项课程均获得较高必要性评价，说明受访者希望培养内容覆盖业务、管理和数据应用。课时分配可结合现有基础与岗位任务进行取舍：共同基础内容统一学习，专项方法放入具体项目中训练。

数智课程需求与现有数据工具培训	已报告现有培训	未勾选现有培训	合计
较高需求	47	109	156
其他需求评价	2	4	6
合计	49	113	162

109人同时表达较高数智课程需求且未勾选现有数据工具培训，占全体受访者67.3%，占数智高需求者69.9%。建议优先了解这部分受访者希望补充的具体内容，将需求转化为数据整理、分析解释、可视化表达和运营决策等实际任务。这里比较的是“ 数智课程需求 ”和“ 已有数据工具培训 ”两个相关题项。

实践培养的具体组合

培养方式的需求覆盖面与首选情况



来源 Q25；每项162人

跟岗实训125人、项目制学习95人、真实案例学习90人列入前三，分别占77.2%、58.6%和55.6%。双导师制被62人列入前三，其中33人将其列为首选，仅次于跟岗的65人。持续指导对一部分受访者具有较高优先级，可与跟岗和项目实践配套实施。

70人报告已有跟岗或轮岗培训方式；72人既偏好跟岗又未报告现有相应方式，占44.4%。可优先安排可观摩、有任务、能反馈的跟岗岗位，使学员逐步从了解流程转向参与分析和形成成果。

7人报告所在机构已实施双导师制，12人报告有意愿并计划一年内启动，91人报告有意愿但条件暂不具备，52人报告暂无意愿。推进时需要先明确业务导师与财务导师的分工、指导时间、工作量认可和阶段反馈要求。

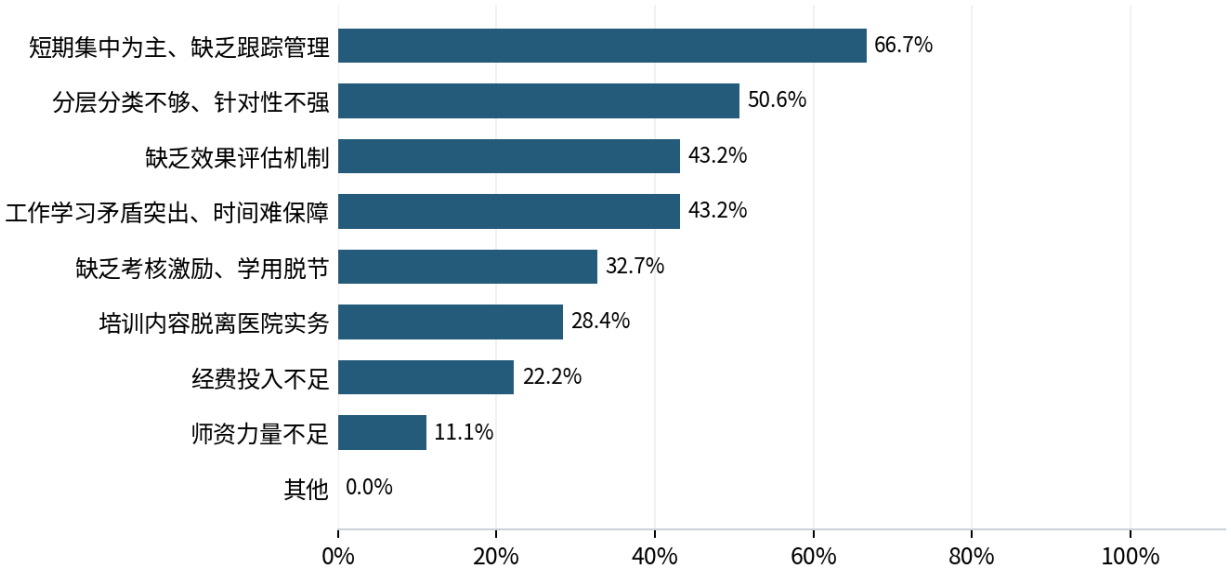
真实项目与基地建设可以相互支撑

148人认为真实管理项目池对培养具有较大支持作用，147人认可实训基地的支持作用。实践基地建设方面，129人选择依托区域龙头医院建立实训基地联盟，119人选择院内设置实训岗位与教学点。建议将区域共享项目与院内实践岗位结合，形成稳定的实训入口。

实战项目中，151人重视运营分析、报告撰写与决策支持，150人重视年度预算编制与执行分析，149人重视成本核算与病种盈亏分析。这些项目可优先纳入课程任务库，并根据学员基础设置不同难度。

六 组织保障与职业发展

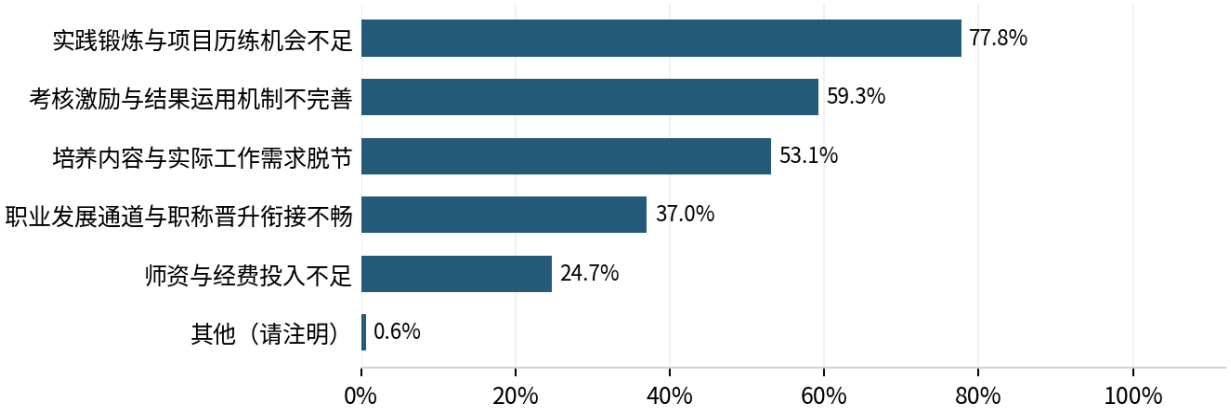
现有培训最需要改进的环节



来源 Q19；每项162人，可选择多项

108人反映培训以短期集中为主、缺乏跟踪管理，占66.7%；82人反映分层分类不够、针对性不强，占50.6%。项目设计应明确学习前目标、过程辅导和培训后应用要求，让课程之间、培训与岗位之间形成连续安排。

培养成果落地的主要障碍



来源 Q46；每项162人，可选择多项

126人反映实践锻炼与项目历练机会不足，占77.8%；96人反映考核激励与结果运用机制不完善，占59.3%。建议在培训启动时就确定成果应用部门和评价人，使学员完成的分析报告、案例或方案能够进入实际工作。

把组织支持落实为可执行安排

152人认为考核激励与培训结果运用较为重要，151人重视经费保障，149人重视组织领导与归口管理。与此同时，153人支持建立分层分类培训体系，149人支持建立岗位胜任力评价体系。培养管理应明确“谁负责、学什么、做什么、如何评价”，并将这些要求写入年度安排。

主管部门支持方向	首选人数	列入前三人数	前三入选率
纳入卫生健康人才发展规划	72	120	74.1%
设立专项培养经费	33	106	65.4%
高端人才计划倾斜	17	68	42.0%
薪酬激励政策	13	60	37.0%
岗位设置与编制保障	11	47	29.0%
学时学分认定与职称衔接	7	43	26.5%
实训基地与师资库建设	9	42	25.9%

120人将纳入卫生健康人才发展规划列入政策支持前三，106人选择专项培养经费。规划与经费可以共同支持稳定的项目周期、导师队伍和实践基地，避免培养安排随单次培训结束而中断。

培养成果应与职业发展机会衔接

153人认为培养结果与职称推荐挂钩较有必要；岗位聘任、薪酬激励和人才计划推荐分别有150人给予较高必要性评价。建议建立清晰的成果标准，将实际应用、问题解决和协作表现作为评价内容，并向参与人员说明成果如何用于后续发展。

职业通道评价中，跨部门轮岗与交流获得较高畅通评价的为75人，占46.3%，在各项通道中相对偏低。结合较高的跟岗需求，可优先完善跨部门交流的岗位安排、参与条件和成果要求，让学习机会与成长路径衔接。

在12份实质开放意见中，7份涉及治理与组织支持，3份涉及职业发展与公平激励，3份涉及实践应用，2份涉及经费或学习实践机会，1份涉及协同与案例共享。一份意见可以涉及多个主题。这些意见进一步提示，应关注组织支持、机会分配与实践落地。

七 分组结果与培养安排

制度落实较好的受访者 更少报告缺乏系统评估

在32名回答制度落实到位的受访者中，9人报告尚无系统评估，占28.1%；在其余130名受访者中，对应为76人，占58.5%。两组相差约30个百分点，体现出制度落实与评价安排之间较清晰的关联。

管理上的启示是：培养制度与评价工具值得同步推进。制定制度时，同时明确过程记录、成果标准与跟踪反馈，能够使管理要求有具体落实载体。这一调查结果反映两者相伴出现，制度的实际效果仍应通过实施后的持续评价来检验。

调查事项	制度落实到位组	其他回答组
无系统评估	9/32（28.1%）	76/130（58.5%）
缺乏培训后跟踪	20/32（62.5%）	88/130（67.7%）
激励结果运用障碍	22/32（68.8%）	74/130（56.9%）

其他回答组包括“有制度但落实不足”和“无系统制度安排”两类。

先看实际任务 再确定分层方式

本次医院类别比较尚未形成足够清晰的差异，暂不宜据此规定“某一层级医院就应采用某一种培养方式”。更实用的安排是先了解学员的业务任务、数据基础、可用学习时间和实践条件，再组合线上学习、跟岗、项目和导师指导。

管理岗位与其他岗位也可以共用业务理解和数据应用的基础课程，再按职责深化。管理人员增加协同决策、项目管理和团队带教任务；具体执行岗位加强数据处理、流程分析和改进方案形成。该安排是实施建议，具体内容应结合岗位需要确定。

按成长阶段安排任务

103人认为合理培养周期为3至5年，占63.6%。分层培养方面，新入职人员、业务骨干、中层管理人员和领军人才对应培养重点的较高认同人数分别为140、145、145和148人。可据此建立逐步进阶的任务体系：新入职人员掌握流程与规范，骨干深化专项分析，中层训练协同与带教，领军人才加强战略与系统治理。

核心方向可先落地 具体强度按人群调整

复核不同答卷组合后，数智课程、跟岗实践和持续跟踪仍是值得关注的方向。不同地区构成下，数据能力高差距比例有所变化，提示各地在安排课时和难度时，应进一步了解本地学员基础。可统一培养框架，同时保留课程深度和实践任务的调整空间。

八 项目实施建议

第一步 确定项目与参与人员

由培养归口部门组织财务、运营、医保、临床和信息部门共同确定试点任务。建议先选取2至3个能够获得数据和业务配合的项目，例如预算执行偏差分析、病种成本与运营分析、医保精细化管理。每个项目明确要解决的问题、业务联系人和预期成果。

选拔参与人员时，可综合考虑实际岗位任务、学习基础和应用机会。对不同基础的学员安排递进任务，让新入职人员、骨干与管理人员在同一项目中承担相适应的职责。

第二步 把课程嵌入项目过程

项目开始前学习相关业务流程与制度；执行过程中学习数据整理、分析和表达方法；阶段结束后进行案例复盘和方案讨论。由业务导师解释场景与流程，由财务或数据导师指导分析方法，使理论学习与实际问题相互连接。

线上内容适合支持基础知识学习和重复练习，集中实训用于需要协作和指导的任务，跟岗用于理解实际流程。具体比例根据岗位和项目条件确定。

第三步 用成果检验学习进展

阶段	具体安排	可查看的成果
启动	明确业务问题与学习目标	任务说明、基线情况和项目计划
实施	开展导师反馈与阶段讨论	数据整理记录、阶段分析和修改记录
结项	业务部门与导师共同评审	分析报告、案例或改进方案
应用	将成果用于实际管理	采纳情况、使用部门反馈和应用记录
跟踪	持续检查应用效果与后续需求	同口径业务指标、复盘记录和下一阶段任务

评价既看学员是否完成任务，也看成果是否进入实际工作。可优先记录报告质量、建议采纳、实际应用和部门反馈，再结合项目特点观察业务指标变化。实施中的问题应及时反馈到课程和导师安排中。

第四步 建立持续培养安排

将年度课程、实践岗位、导师指导和项目评价纳入统一安排；把成熟案例沉淀为案例库，把适合重复训练的任务形成项目清单。对成效较好的试点逐步扩大，对参与困难或应用不足的环节调整资源和组织方式。

总体而言，本次调查支持以业务与数据能力为共同重点，以运营管理项目为主要应用场景，以跟岗、案例和导师指导为支撑，并通过持续评价促进成果运用。培养质量的提升，需要课程内容、实践机会和组织保障同步推进。

附录A 各题统计结果

本附录按原题顺序列出全部题目。除Q11、Q12和Q47专门分母外，表中人数均为答卷数。量表分布依次为1至5分人数，高分为4至5分；Q22与Q35含义不同，必须连同题目锚点阅读。多选和排序选项保留原始术语，其他项的自由填写内容不公开。

Q1 (1)1.贵院所在省份:___

选项	人数	分母	比例
江苏	38	162	23.5%
河南	33	162	20.4%
上海	20	162	12.3%
广西	17	162	10.5%
浙江	14	162	8.6%
北京	8	162	4.9%
湖北	5	162	3.1%
吉林	5	162	3.1%
湖南	4	162	2.5%
四川	4	162	2.5%
广东	4	162	2.5%
山东	3	162	1.9%
天津	2	162	1.2%
陕西	2	162	1.2%
云南	2	162	1.2%
河北	1	162	0.6%

数据来源 数值版 Sheet1!G2:H163

Q2 2.贵院类别（单选）

选项	人数	分母	比例
三级综合医院	106	162	65.4%
三级专科医院	39	162	24.1%
二级综合医院	13	162	8.0%
二级专科医院	1	162	0.6%
其他（请注明）	3	162	1.9%

数据来源 数值版 Sheet1!I2:I163

Q3 3.您所在部门（单选）

选项	人数	分母	比例
领导班子成员	19	162	11.7%
财务部门	92	162	56.8%
审计部门	17	162	10.5%
运营管理部门	22	162	13.6%
医保管理部门	1	162	0.6%
绩效/人事部门	5	162	3.1%
院办/综合管理部门	1	162	0.6%
其他	5	162	3.1%

数据来源 数值版 Sheet1!J2:J163

Q4 4.您的职务（单选）

选项	人数	分母	比例
院级领导	6	162	3.7%
总会计师	14	162	8.6%
部门正职	41	162	25.3%
部门副职	30	162	18.5%
其他	71	162	43.8%

数据来源 数值版 Sheet1!K2:K163

Q5 5.您的年龄（单选）

选项	人数	分母	比例
51岁及以上	18	162	11.1%
41—50岁	43	162	26.5%
31—40岁	99	162	61.1%
30岁及以下	2	162	1.2%

数据来源 数值版 Sheet1!L2:L163

Q6 6.您的最高学历（单选）

选项	人数	分母	比例
博士	3	162	1.9%
硕士	88	162	54.3%
本科	70	162	43.2%
大专及以下	1	162	0.6%

数据来源 数值版 Sheet1!M2:M163

Q7 7.您的专业背景（单选）

选项	人数	分母	比例
财会审计类	142	162	87.7%
医疗/护理类	1	162	0.6%
卫生管理类	5	162	3.1%
经济金融类	9	162	5.6%
信息技术类	3	162	1.9%
其他	2	162	1.2%

数据来源 数值版 Sheet1!N2:N163

Q8 8.您的职称（单选）

选项	人数	分母	比例
正高级	25	162	15.4%
副高级	50	162	30.9%
中级	83	162	51.2%
初级及以下	1	162	0.6%
未评聘	3	162	1.9%

数据来源 数值版 Sheet1!O2:O163

Q9 9.您从事卫生健康经济管理相关工作的年限（单选）

选项	人数	分母	比例
20年以上	40	162	24.7%
11—20年	67	162	41.4%
6—10年	45	162	27.8%
3—5年	7	162	4.3%
3年以下	3	162	1.9%

数据来源 数值版 Sheet1!P2:P163

Q10 10.贵院岗位与机构设置情况（分别勾选）—设置总会计师岗位

项目	是	否	分母	是比例
设置总会计师岗位	109	53	162	67.3%
设立独立运营管理部门	102	60	162	63.0%
设置独立医保管理部门	151	11	162	93.2%
设置独立内部审计部门	150	12	162	92.6%
明确经济管理人员培养归口管理部门	76	86	162	46.9%

数据来源 数值版 Sheet1!Q2:U163

Q11 (1)11.贵院经济管理人员队伍结构（填写人数，本部分所称经济管理人员，是指总会计师、财务（不含窗口收费人员）、审计、运营、合规、医保、绩效等部门人员，下同。） 在岗总人数___

项目	填报记录数	记录计数和	中位数	最大值
在岗总人数	98	12573	27.0	5300
其中:博士	92	523	0.0	500
硕士	90	1909	4.5	1300
本科	91	5992	18.0	2500
大专及以下	88	1672	2.0	1000
职称:正高级	90	479	1.0	300
副高级	91	1544	3.0	800
中级	88	3086	10.0	1500
初级及以下	89	4117	9.0	2700
专业背景:财会审计类	91	1985	17.0	100
医疗/护理类	85	5495	1.0	4100
卫生管理类	84	602	0.0	300
信息技术类	84	294	0.0	200
经济金融类	84	193	0.0	50
其他	82	944	0.0	500

本题按各字段实际填报记录统计。记录计数和为填写数值之和，不作为去重后的人员规模或整体人员结构。

数据来源 数值版 Sheet1!V2:AJ163

Q12 (1)12.贵院经济管理人员中持有会计、审计、经济专业技术资格或CPA/CMA/CIA等职业资格的人员情况（同一人持有多项资格的分别计入） 正高级专业技术资格___

项目	填报记录数	记录计数和	中位数	最大值
正高级专业技术资格	92	99	1.0	5
副高级专业技术资格	93	329	2.0	21
中级专业技术资格	89	799	6.0	36
初级及以下专业技术资格	89	971	7.0	44
注册会计师（CPA）	87	91	1.0	5
管理会计师（CMA）	82	32	0.0	13

同一人持有多项资格可分别计入。各项按实际填报记录统计，资格计数不相加为独立持证人数。

数据来源 数值版 Sheet1!AK2:AP163

Q13 13.贵院经济管理人员配置的充足程度（单选）

选项	人数	分母	比例
严重不足	10	162	6.2%
相对不足	72	162	44.4%
基本满足	68	162	42.0%
比较充足	12	162	7.4%

数据来源 数值版 Sheet1!AQ2:AQ163

Q14 14.当前最紧缺的岗位（可多选，最多3项）

选项	选择人数	分母	选择率
成本核算	68	162	42.0%
预算管理	36	162	22.2%
运营分析	93	162	57.4%
医保管理	21	162	13.0%
内部审计	17	162	10.5%
物价管理	11	162	6.8%
绩效管理	21	162	13.0%
数据分析/信息化	103	162	63.6%
综合财务管理	63	162	38.9%

数据来源 数值版 Sheet1!AR2:AZ163

Q15 15.贵院是否建立了经济管理人员培养培训制度并落实到位（单选）

选项	人数	分母	比例
有制度且落实到位	32	162	19.8%
有制度但落实不足	49	162	30.2%
无系统制度安排	81	162	50.0%

数据来源 数值版 Sheet1!BA2:BA163

Q16 16.贵院经济管理人员年人均培训学时（单选）

选项	人数	分母	比例
20学时以下	50	162	30.9%
20—40学时	53	162	32.7%
41—60学时	21	162	13.0%
61—90学时	20	162	12.3%
90学时以上	18	162	11.1%

数据来源 数值版 Sheet1!BB2:BB163

Q17 17.贵院现有培养培训的内容（可多选）

选项	选择人数	分母	选择率
会计准则与制度	112	162	69.1%
预算绩效管理	100	162	61.7%
DRG/DIP与医保政策	97	162	59.9%
成本核算	83	162	51.2%
信息化与数据工具	49	162	30.2%
管理沟通与领导力	30	162	18.5%
政策法规与合规	85	162	52.5%
其他	5	162	3.1%

数据来源 数值版 Sheet1!BC2:BJ163

Q18 18.贵院现有培养培训的方式（可多选）

选项	选择人数	分母	选择率
院内讲座	90	162	55.6%
外派短期集中培训	122	162	75.3%
学历学位教育	55	162	34.0%
跟岗学习/轮岗	70	162	43.2%
线上课程	90	162	55.6%
导师制带教	10	162	6.2%
学术会议与专题研讨	67	162	41.4%

数据来源 数值版 Sheet1!BK2:BQ163

Q19 19.当前培养培训工作存在的主要问题（可多选，最多4项）

选项	选择人数	分母	选择率
培训内容脱离医院实务	46	162	28.4%
短期集中为主、缺乏跟踪管理	108	162	66.7%
缺乏效果评估机制	70	162	43.2%
分层分类不够、针对性不强	82	162	50.6%
师资力量不足	18	162	11.1%
工作学习矛盾突出、时间难保障	70	162	43.2%
缺乏考核激励、学用脱节	53	162	32.7%
经费投入不足	36	162	22.2%
其他	0	162	0.0%

数据来源 数值版 Sheet1!BR2:BZ163

Q20 20.贵院业财融合推进程度（单选）

选项	人数	分母	比例
尚未起步	7	162	4.3%
试点探索	35	162	21.6%
部分领域推进	84	162	51.9%
全面推进	31	162	19.1%
深度融合发展	5	162	3.1%

数据来源 数值版 Sheet1!CA2:CA163

Q21 21.贵院业财融合已实施的管理举措（可多选）

选项	选择人数	分母	选择率
DRG/DIP医保支付方式改革	109	162	67.3%
全面预算管理	127	162	78.4%
全成本核算	102	162	63.0%
公立医院绩效考核	121	162	74.7%
内部控制建设与财会监督	101	162	62.3%
智慧医院/运营数据中心建设	73	162	45.1%
其他	0	162	0.0%

数据来源 数值版 Sheet1!CB2:CH163

Q22 22.现有队伍与“ 懂业务、通财务、善管理、会数据、防风险 ”复合型人才要求的差距有多大?请在相应栏内打“ √ ”（1=差距很小，5=差距很大） —D1 懂业务:理解医疗业务流程与临床运行规律

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
D1 懂业务:理解医疗业务流程与临床运行规律	8 / 20 / 68 / 47 / 19	3.30±1.00	66/162	40.7%
D2 通财务:掌握财务、预算、成本专业知识	33 / 44 / 43 / 29 / 13	2.66±1.22	42/162	25.9%
D3 善管理:具备运营管理与综合协调能力	7 / 32 / 78 / 29 / 16	3.09±0.97	45/162	27.8%
D4 会数据:具备数字化工具与数据分析能力	14 / 22 / 69 / 43 / 14	3.13±1.04	57/162	35.2%
D5 防风险:具备内控、审计与合规监督能力	10 / 39 / 64 / 36 / 13	3.02±1.02	49/162	30.2%

数据来源 数值版 Sheet1!CI2:CM163

Q23 23.未来3年贵院最急需的经济管理人才类型（请排序前3位，1=最急需，2=次之，3=再次之）

选项	第1	第2	第3	前三人数	首选率	前三率
成本与预算管理人才	29	24	30	83	17.9%	51.2%
运营管理人才	67	43	23	133	41.4%	82.1%
医保管理人才	6	19	17	42	3.7%	25.9%
内审与监督人才	3	3	13	19	1.9%	11.7%
数据分析人才	23	57	40	120	14.2%	74.1%
综合管理人才	34	16	39	89	21.0%	54.9%

数据来源 数值版 Sheet1!CN2:CS163

Q24 24.对分层分类培养模式各层级培养重点的认同程度（1=很不认同，5=很认同），请在相应栏内打“ √ ”—E1 新入职人员:夯实财务、医疗、管理、信息交叉基础，强化跟岗实训与基本制度规范

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
E1 新入职人员:夯实财务、医疗、管理、信息交叉基础，强化跟岗实训与基本制度规范	5 / 4 / 13 / 29 / 111	4.46±0.97	140/162	86.4%
E2 业务骨干人员:围绕预算绩效、成本核算、数智运营、风控监督等专项能力系统深化	4 / 1 / 12 / 26 / 119	4.57±0.85	145/162	89.5%
E3 中层管理人员:提升运营管理、跨部门协同与团队带教能力	4 / 2 / 11 / 25 / 120	4.57±0.87	145/162	89.5%
E4 领军人才（总会计师及院领导）:提升战略思维、行业引领与穿透式监管能力	5 / 1 / 8 / 25 / 123	4.60±0.87	148/162	91.4%

数据来源 数值版 Sheet1!CT2:CW163

Q25 25.您认为最有效的培养方式（请选出3项并排序，1=最有效，2=次之，3=再次之）

选项	第1	第2	第3	前三人数	首选率	前三率
双导师制（业务导师+财务导师）	33	8	21	62	20.4%	38.3%
跟岗实训/实训医院	65	44	16	125	40.1%	77.2%
真实案例教学与案例库	21	39	30	90	13.0%	55.6%
项目制学习（参与实际管理项目）	30	33	32	95	18.5%	58.6%
学历学位教育	1	3	6	10	0.6%	6.2%
短期专题研修	1	12	15	28	0.6%	17.3%
线上自主学习平台	2	1	1	4	1.2%	2.5%
跨部门交流挂职	9	22	41	72	5.6%	44.4%

数据来源 数值版 Sheet1!CX2:DE163

Q26 26.下列课程模块对人才培养的必要程度（1=很没必要，5=很有必要），请在相应栏内打“ √ ”—F1 战略管理与领导力

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
F1 战略管理与领导力	0 / 5 / 26 / 49 / 82	4.28±0.84	131/162	80.9%
F2 卫生政策与财经法规	0 / 2 / 13 / 41 / 106	4.55±0.70	147/162	90.7%
F3 医疗业务流程与临床认知	0 / 1 / 11 / 49 / 101	4.54±0.65	150/162	92.6%
F4 跨部门沟通与协同管理	0 / 0 / 10 / 42 / 110	4.62±0.60	152/162	93.8%
F5 DRG/DIP与医保精细化管理	0 / 1 / 12 / 44 / 105	4.56±0.66	149/162	92.0%
F6 预算管理与绩效评价	0 / 2 / 9 / 44 / 107	4.58±0.66	151/162	93.2%
F7 成本核算与运营分析	0 / 1 / 5 / 45 / 111	4.64±0.58	156/162	96.3%
F8 数智化运营与数据分析	0 / 0 / 6 / 37 / 119	4.70±0.54	156/162	96.3%
F9 内部控制、审计与风险防控	0 / 1 / 17 / 38 / 106	4.54±0.71	144/162	88.9%
F10 科教管理与成果转化	1 / 10 / 37 / 54 / 60	4.00±0.95	114/162	70.4%

数据来源 数值版 Sheet1!DF2:DO163

Q27 27.下列培养方式对人才培养的支持作用（1=作用很小，5=作用很大），请在相应栏内打“ √ ”—G1 案例库与教学案例开发

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
G1 案例库与教学案例开发	1 / 3 / 18 / 53 / 87	4.37±0.80	140/162	86.4%
G2 实训基地（实训医院）	0 / 1 / 14 / 47 / 100	4.52±0.68	147/162	90.7%
G3 线上学习平台与移动微课堂	3 / 13 / 44 / 55 / 47	3.80±1.01	102/162	63.0%
G4 真实管理项目池（项目制学习）	0 / 2 / 12 / 51 / 97	4.50±0.69	148/162	91.4%
G5 虚拟运营沙盘演练	5 / 7 / 41 / 56 / 53	3.90±1.01	109/162	67.3%

数据来源 数值版 Sheet1!DP2:DT163

Q28 28.贵院与院校、专业机构的合作形式（可多选）

选项	选择人数	分母	选择率
共建课程体系	44	162	27.2%
共建案例库	35	162	21.6%
共建实践基地	49	162	30.2%
联合开展岗位能力评价	17	162	10.5%
互派师资/导师	13	162	8.0%
委托开展专项培训	49	162	30.2%
尚无合作	80	162	49.4%

数据来源 数值版 Sheet1!DU2:EA163

Q29 29.贵院与院校、专业机构的“ 业务导师+财务导师 ”双导师制（单选）

选项	人数	分母	比例
已实施	7	162	4.3%
有意愿、一年内启动	12	162	7.4%
有意愿但条件暂不具备	91	162	56.2%
暂无意愿	52	162	32.1%

数据来源 数值版 Sheet1!EB2:EB163

Q30 30.贵院对培养效果的评估与结果运用方式（可多选）

选项	选择人数	分母	选择率
阶段性测试或结业考核	43	162	26.5%
培训前后绩效指标对照	37	162	22.8%
成果汇报与案例产出	70	162	43.2%
培训结果与考核、聘任挂钩	22	162	13.6%
尚无系统评估	85	162	52.5%

数据来源 数值版 Sheet1!EC2:EG163

Q31 31.您认为经济管理骨干成长为复合型人才所需的合理培养周期（单选）

选项	人数	分母	比例
3年以下	23	162	14.2%
3—5年	103	162	63.6%
6—10年	28	162	17.3%
10年及以上	8	162	4.9%

数据来源 数值版 Sheet1!EH2:EH163

Q32 32.下列院内长效保障机制对人才培养落地的重要程度（1=很不重要，5=很重要），请在相应栏内打“ √ ”—H1 组织领导与归口管理

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
H1 组织领导与归口管理	0 / 2 / 11 / 39 / 110	4.59±0.67	149/162	92.0%
H2 岗位设置与总会计师制度落实	1 / 1 / 17 / 47 / 96	4.46±0.76	143/162	88.3%
H3 师资队伍建设（双师型、行业导师库）	0 / 5 / 20 / 60 / 77	4.29±0.80	137/162	84.6%
H4 经费投入保障	0 / 3 / 8 / 47 / 104	4.56±0.68	151/162	93.2%
H5 考核激励与培训结果运用	0 / 2 / 8 / 44 / 108	4.59±0.65	152/162	93.8%
H6 职业发展通道与职称晋升衔接	0 / 2 / 5 / 41 / 114	4.65±0.61	155/162	95.7%
H7 学习时间保障与安排	0 / 2 / 13 / 46 / 101	4.52±0.70	147/162	90.7%
H8 信息化学习平台与培训档案管理	0 / 2 / 26 / 61 / 73	4.27±0.77	134/162	82.7%

数据来源 数值版 Sheet1!EI2:EP163

Q33 33.对下列人才培养体系机制建设的认同程度（1=很不支持，5=很支持），请在相应栏内打“ √ ”—I1 建立分层分类培训体系

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
I1 建立分层分类培训体系	0 / 1 / 8 / 45 / 108	4.60±0.61	153/162	94.4%
I2 建立岗位胜任力评价体系	0 / 1 / 12 / 45 / 104	4.56±0.66	149/162	92.0%
I3 建立行业经济管理人才库	0 / 1 / 16 / 43 / 102	4.52±0.70	145/162	89.5%
I4 建立行业师资库与课程认证制度	0 / 1 / 18 / 49 / 94	4.46±0.71	143/162	88.3%
I5 继续教育学分与职称评审衔接制度	1 / 3 / 16 / 48 / 94	4.43±0.79	142/162	87.7%

数据来源 数值版 Sheet1!EQ2:EU163

Q34 34.培养结果与考核激励挂钩方式的选择（单选;下列挂钩方式的必要程度1=很没必要，5=很有必要），请在相应栏内打"√" —J1 评优评先

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
J1 评优评先	2 / 4 / 18 / 38 / 100	4.42±0.88	138/162	85.2%
J2 岗位聘任	1 / 4 / 7 / 37 / 113	4.59±0.74	150/162	92.6%
J3 薪酬激励	1 / 5 / 6 / 38 / 112	4.57±0.76	150/162	92.6%
J4 职称推荐	1 / 3 / 5 / 39 / 114	4.62±0.70	153/162	94.4%
J5 人才计划推荐	1 / 2 / 9 / 37 / 113	4.60±0.71	150/162	92.6%

数据来源 数值版 Sheet1!EV2:EZ163

Q35 35.贵院经济管理人员职业发展通道各环节的畅通程度（1=严重梗阻，5=非常畅通），请在相应栏内打"√"—K1 职称评审与聘任通道

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
K1 职称评审与聘任通道	9 / 14 / 41 / 48 / 50	3.72±1.16	98/162	60.5%
K2 岗位层级与职务晋升通道	8 / 15 / 50 / 46 / 43	3.62±1.12	89/162	54.9%
K3 跨部门轮岗与交流通道	8 / 23 / 56 / 36 / 39	3.46±1.15	75/162	46.3%
K4 专业能力进阶与培训通道	5 / 8 / 53 / 47 / 49	3.78±1.03	96/162	59.3%
K5 领军人才与后备人才成长通道	7 / 10 / 52 / 46 / 47	3.72±1.08	93/162	57.4%
K6 薪酬待遇与个人价值体现	5 / 17 / 49 / 52 / 39	3.64±1.06	91/162	56.2%

数据来源 数值版 Sheet1!FA2:FF163

Q36 36.贵院经济管理人员年人均培训经费（单选）

选项	人数	分母	比例
1000元以下	48	162	29.6%
1000—3000元	62	162	38.3%
3000—5000元	31	162	19.1%
5000—10000元	14	162	8.6%
10000元以上	7	162	4.3%

数据来源 数值版 Sheet1!FG2:FG163

Q37 37.贵院经济管理人员培养经费来源（可多选）

选项	选择人数	分母	选择率
单位预算安排	148	162	91.4%
主管部门专项经费	62	162	38.3%
学会/协会项目支持	30	162	18.5%
个人承担	33	162	20.4%
其他	2	162	1.2%

数据来源 数值版 Sheet1!FH2:FL163

Q38 38.您最希望主管部门出台的政策支持（请排序前3位，1=最迫切，2=次之，3=再次之）

选项	第1	第2	第3	前三人数	首选率	前三率
纳入卫生健康人才发展规划	72	27	21	120	44.4%	74.1%
设立专项培养经费	33	46	27	106	20.4%	65.4%
学时学分认定与职称衔接	7	14	22	43	4.3%	26.5%
高端人才计划倾斜	17	23	28	68	10.5%	42.0%
实训基地与师资库建设	9	16	17	42	5.6%	25.9%
岗位设置与编制保障	11	16	20	47	6.8%	29.0%
薪酬激励政策	13	20	27	60	8.0%	37.0%

数据来源 数值版 Sheet1!FM2:FS163

Q39 39.贵院人才培养组织管理情况（分别勾选）—成立人才培养领导小组

项目	是	否	分母	是比例
成立人才培养领导小组	47	115	162	29.0%
明确人才培养归口管理部门	91	71	162	56.2%
制定中长期人才培养规划	69	93	162	42.6%
建立培养档案与学时台账	51	111	162	31.5%

数据来源 数值版 Sheet1!FT2:FW163

Q40 40.对“ 在校培养—岗位适应—能力提升—领军人才 ”四阶段全链条培养路径各环节重点的认同程度（1=很不认同，5=很认同），请在相应栏内打“ √ ”—L1 在校培养阶段:夯实财务、医疗、管理、信息交叉基础知识

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
L1 在校培养阶段:夯实财务、医疗、管理、信息交叉基础知识	1 / 1 / 11 / 42 / 107	4.56±0.70	149/162	92.0%
L2 岗位适应阶段:通过跟岗实训、轮岗实现实务能力转化	1 / 1 / 9 / 36 / 115	4.62±0.68	151/162	93.2%
L3 能力提升阶段:围绕预算绩效、数智运营、合规风控等专项系统深化进修	1 / 1 / 9 / 29 / 122	4.67±0.67	151/162	93.2%
L4 领军人才阶段:提升战略思维与行业引领、穿透式监管能力	1 / 0 / 10 / 32 / 119	4.65±0.65	151/162	93.2%

数据来源 数值版 Sheet1!FX2:GA163

Q41 41.贵院经济管理人员跨部门轮岗开展情况（单选）

选项	人数	分母	比例
常态化开展	38	162	23.5%
偶尔开展	80	162	49.4%
从未开展	44	162	27.2%

数据来源 数值版 Sheet1!GB2:GB163

Q42 42.贵院经济管理人员跨部门轮岗频次（单选）

选项	人数	分母	比例
每年一轮	6	162	3.7%
每三年一轮	30	162	18.5%
每五年一轮	36	162	22.2%
其他	90	162	55.6%

数据来源 数值版 Sheet1!GC2:GC163

Q43 43.下列实战项目历练对能力提升的重要程度（1=很不重要，5=很重要），请在相应栏内打“ √ ”—M1 参与年度预算编制与执行分析

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
M1 参与年度预算编制与执行分析	0 / 4 / 8 / 39 / 111	4.59±0.70	150/162	92.6%
M2 参与成本核算与病种盈亏分析项目	0 / 1 / 12 / 29 / 120	4.65±0.64	149/162	92.0%
M3 参与内部控制建设与内部控制评价	0 / 2 / 14 / 47 / 99	4.50±0.71	146/162	90.1%
M4 参与运营分析、报告撰写与决策支持	0 / 0 / 11 / 30 / 121	4.68±0.60	151/162	93.2%
M5 参与审计监督与财会监督	0 / 3 / 16 / 48 / 95	4.45±0.75	143/162	88.3%
M6 参与绩效分配方案设计与更正	0 / 2 / 16 / 46 / 98	4.48±0.72	144/162	88.9%
M7 参与医保收费、物价检查	0 / 1 / 19 / 46 / 96	4.46±0.72	142/162	87.7%

数据来源 数值版 Sheet1!GD2:GJ163

Q44 44.您认为可行的实践基地建设路径（可多选）

选项	选择人数	分母	选择率
院内设立实训岗位与教学点	119	162	73.5%
依托区域龙头医院建立实训基地联盟	129	162	79.6%
依托第三方共建实践基地	88	162	54.3%
其他（请注明）	1	162	0.6%

数据来源 数值版 Sheet1!GK2:GN163

Q45 45.贵院培养成果转化途径（可多选）

选项	选择人数	分母	选择率
改进工作:将培养成果转化为实际管理改进举措	139	162	85.8%
案例总结:提炼形成典型案例并交流推广	126	162	77.8%
决策参考:形成分析建议，为领导决策提供参考	131	162	80.9%
其他（请注明）	0	162	0.0%

数据来源 数值版 Sheet1!GO2:GR163

Q46 46.您认为培养成果难以转化落地的主要障碍是（可多选，最多3项）

选项	选择人数	分母	选择率
培养内容与实际工作需求脱节	86	162	53.1%
实践锻炼与项目历练机会不足	126	162	77.8%
考核激励与结果运用机制不完善	96	162	59.3%
职业发展通道与职称晋升衔接不畅	60	162	37.0%
师资与经费投入不足	40	162	24.7%
其他（请注明）	1	162	0.6%

数据来源 数值版 Sheet1!GS2:GX163

Q47 47.您对业财融合视角下卫生健康经济管理人才培养模式、机制建设与实践路径的意见建议:

主题	涉及意见数	实质意见分母	意见内比例
治理与组织支持	7	12	58.3%
职业发展与公平激励	3	12	25.0%
实践应用	3	12	25.0%
经费或学习实践机会	2	12	16.7%
协同与案例共享	1	12	8.3%

数据来源 文本版 Sheet1!DY2:DY163；数值版GY2:GY163仅用于有无意见计数

附录B 统计方法与比较结果

Q22全部配对比较

维度对	均值差	95%区间	精确p	10对BH q
D1 懂业务 / D2 通财务	0.642	0.442 至 0.842	2.1e-09	2.1e-08
D1 懂业务 / D3 善管理	0.210	0.064 至 0.356	0.0064	0.0106
D1 懂业务 / D4 会数据	0.173	0.006 至 0.340	0.0505	0.0721
D1 懂业务 / D5 防风险	0.284	0.104 至 0.464	0.0026	0.0052
D2 通财务 / D3 善管理	-0.432	-0.580 至 -0.284	3.01e-08	1.5e-07
D2 通财务 / D4 会数据	-0.469	-0.656 至 -0.283	2e-06	6.67e-06
D2 通财务 / D5 防风险	-0.358	-0.507 至 -0.209	4.29e-06	1.07e-05
D3 善管理 / D4 会数据	-0.037	-0.165 至 0.091	0.6368	0.6368
D3 善管理 / D5 防风险	0.074	-0.049 至 0.197	0.2790	0.3100
D4 会数据 / D5 防风险	0.111	-0.040 至 0.262	0.1715	0.2143

差值方向为表内第一维度减第二维度；区间未作多重比较调整。区间与精确检验采用不同方法，在临界值附近可能产生轻微边界差异，应以完整方法与效应大小解释。

医院类别12项

比较方向 三级类别 减 二级类别

结局	组1 n/N	组0 n/N	差值百分点	p	BH q
业务能力高差距	58/145	8/14	-17.1	0.2607	0.7821
财务能力高差距	35/145	6/14	-18.7	0.1961	0.7821
管理能力高差距	40/145	4/14	-1.0	1.0000	1.0000
数据能力高差距	49/145	6/14	-9.1	0.5605	1.0000
风险能力高差距	44/145	4/14	1.8	1.0000	1.0000
数智课程高需求	139/145	14/14	-4.1	1.0000	1.0000
跟岗进入前三	111/145	11/14	-2.0	1.0000	1.0000
无系统评估	73/145	10/14	-21.1	0.1660	0.7821
制度落实到位	30/145	2/14	6.4	0.7373	1.0000
常态化轮岗	35/145	3/14	2.7	1.0000	1.0000
人员配置不足	69/145	11/14	-31.0	0.0468	0.5621
培训经费前两档	98/145	9/14	3.3	0.7735	1.0000

职务分组12项

比较方向 Q4编码1至4 减 Q4其他

结局	组1 n/N	组0 n/N	差值百分点	p	BH q
业务能力高差距	29/91	37/71	-20.2	0.0104	0.1251
财务能力高差距	22/91	20/71	-4.0	0.5916	0.7888
管理能力高差距	21/91	24/71	-10.7	0.1581	0.3798
数据能力高差距	28/91	29/71	-10.1	0.1899	0.3798
风险能力高差距	22/91	27/71	-13.9	0.0608	0.3273
数智课程高需求	89/91	67/71	3.4	0.4057	0.6086
跟岗进入前三	74/91	51/71	9.5	0.1876	0.3798
无系统评估	42/91	43/71	-14.4	0.0818	0.3273
制度落实到位	19/91	13/71	2.6	0.8426	0.8426
常态化轮岗	24/91	14/71	6.7	0.3548	0.6083
人员配置不足	45/91	37/71	-2.7	0.7539	0.8224
培训经费前两档	63/91	47/71	3.0	0.7357	0.8224

制度落实3项

比较方向 有制度且落实到位 减 其他回答

结局	组1 n/N	组0 n/N	差值百分点	p	BH q
无系统评估	9/32	76/130	-30.3	0.0028	0.0083
缺乏培训后跟踪	20/32	88/130	-5.2	0.6760	0.6760
激励结果运用障碍	22/32	74/130	11.8	0.2369	0.3554

统计口径与复现说明

正文人数以162名受访者为基础，不作为独立医院数量或全国总体估计。单选与多选按选择人数统计；量表报告各分值人数与均值；排序分别统计首选和前三入选。第11、12题按字段统计实际填报记录，保留零值；选答题未填写不影响其他题目的分析。

二元比例区间使用Wilson方法；分组比较使用双侧Fisher精确检验，比例差区间使用Newcombe方法。医院类别12项、职务12项、制度落实3项分别进行BH多重比较校正；区间未作多重比较调整。分组结果用于观察关联，未作因果解释。

Q22五维比较采用Friedman检验，统计量66.65，p=1.16e-13，Kendall W=0.103。10对维度比较采用精确符号翻转置换并共同BH校正；均值差区间采用配对t近似。评分按近似等距处理，置换检验要求零假设下差值符号可交换。

原始数值版与文本版按答卷序号对齐，32562个实质字段单元格核验一致。两份文件属于同一批162份答卷。分析脚本和聚合统计保存在配套复现包中；完整计算与核验记录见统计工作簿。

复现入口：analyze.py读取原始两个导出文件并生成聚合JSON与CSV；build_report.py根据聚合数据生成本报告；export_aggregate_xlsx.py导出统计表。运行环境和步骤见复现包说明。公开附件仅含汇总结果，原始答卷由数据持有人自行保管。